

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DIAGNÓSTICA DEL ESPECTRO BIPOLAR (BSDS)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Sensible de Trastorno Bipolar Tipo II, Ciclotimia y Espectro Suave

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala Diagnóstica del Espectro Bipolar (BSDS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Bipolar Spectrum Diagnostic Scale (BSDS)</i>
Autores Originales	Ronald W. Pies (diseño original narrativo); validado por S. Nassir Ghaemi et al. (2005).
Adaptaciones Españolas	Bulbena et al. (2011, validación clínica española); Grupo de Trastornos Bipolares de Barcelona.
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Detección de bipolaridad sutil, ciclotimia y distimia bifásica.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de formato narrativo mixto: historia vital de 19 frases más pregunta de concordancia global.
Población y Rango	Adultos y jóvenes (≥ 16 años). Pacientes con queja de depresión o inestabilidad afectiva recurrente.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación psiquiátrica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y EL PARADIGMA NARRATIVO

La escala BSDS fue concebida por Ronald Pies y perfeccionada empíricamente por Nassir Ghaemi (2005) para subsanar la debilidad metodológica más severa de los cuestionarios bipolares tradicionales (como el MDQ): su incapacidad para captar las formas “blandas” o intermedias del espectro (Trastorno Bipolar Tipo II, Ciclotimia y Estados Mixtos atenuados).

A menudo los pacientes con hipomanía no reconocen preguntas directas y estigmatizantes sobre “haberse sentido grandioso” o “haber tenido exceso de energía”. La BSDS sortea este obstáculo adoptando un **método narrativo desculpabilizador**: presenta una viñeta biográfica en tercera persona que describe a individuos cuyos niveles de energía, sociabilidad y estado de ánimo oscilan en ciclos impredecibles. El paciente simplemente subraya las frases con las que se siente identificado y puntúa la concordancia global, permitiendo revelar la labilidad afectiva subyacente.

3. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA BSDS (GHAEMI ET AL., 2005)

Componente Estructural	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Clínica
Parte 1: Historia Narrativa	19 frases	0 a 19	Identificación de oscilaciones drásticas de energía, hipersomnia versus hiposomnia, productividad discontinua, verborrea e irritabilidad.
Parte 2: Ajuste Global	1 pregunta	0 a 6	Valoración sintética de cuánto describe la historia global la propia vida: No describe (0), Poco (2), Bastante (4) o Totalmente (6).
PUNTUACIÓN TOTAL BSDS	19 + 1	0 a 25	Índice continuo de probabilidad y gravedad del espectro afectivo bipolar.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Sensibilidad en Bipolar II	Rendimiento superior al MDQ para Trastorno Bipolar Tipo II: sensibilidad del 76% al 82% frente a entrevistas SCID-IV en estudios de validación (Ghaemi et al., 2005; Bulbena et al., 2011).
Especificidad Diagnóstica	Especificidad global del 85% al 93% en la diferenciación de pacientes con depresión monopolar y trastornos de la personalidad sin ciclotimia.
Consistencia Interna	Excelente coherencia: coeficiente alfa de Cronbach de 0.87 a 0.89 en muestras clínicas psiquiátricas ambulatorias.
Validez Concurrente	Elevada correlación con el MDQ ($r = 0.68$) y con la Escala de Manía de Young (YMRS $r = 0.54$ en episodios hipomaniacos activos).
Poder Discriminante	Distingue eficazmente la inestabilidad ciclotímica de la reactividad emocional situacional común.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE LA ESCALA

El cómputo de la BSDS integra dos componentes cuantitativos complementarios:

- **Cálculo de la Parte 1 (Historia Narrativa):** Cada frase de la viñeta que el paciente marca como coincidente con su experiencia vital suma **1 punto**. Las frases omitidas puntúan 0. (Subtotal Parte 1: **0 a 19 puntos**).
- **Cálculo de la Parte 2 (Grado de Ajuste Vital):** La respuesta a la pregunta final de encaje narrativo se pondera de la siguiente manera:

No describe = 0 pts | Poco = 2 pts | Bastante = 4 pts | A la perfección = 6 pts

- **Puntuación Total BSDS:** Suma directa de la Parte 1 más la Parte 2. Rango de puntuación: **0 a 25 puntos**.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (GHAEMI ET AL., 2005)

Rango	Puntuación	Probabilidad de Espectro	Conducta Asistencial Recomendada
Mínimo	0 a 6	Bipolaridad muy improbable	Cuadro congruente con depresión monopolar unipolar pura o distimia simple.
Bajo/Medio	7 a 12	Baja a moderada probabilidad	Rasgos atenuados o labilidad afectiva situacional. Monitorizar sin prescribir eutimizantes sin reevaluación.
Moderado	13 a 19	Probabilidad Moderada / Sospecha	Corte sensible para Trastorno Bipolar Tipo II y Ciclotimia. Explorar a fondo antecedentes familiares.
Alto	20 a 25	Altamente Probable Bipolar	Diagnóstico muy firme de Trastorno del Espectro Bipolar. Intervención farmacológica especializada prioritaria.

COMPLEMENTARIEDAD ENTRE MDQ Y BSDS: En pacientes donde el MDQ resulte negativo pero exista historia de múltiples fracasos antidepresivos, la BSDS suele capturar la bipolaridad latente gracias a su formato narrativo no amenazante.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y MANEJO EN CICLOTIMIA

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y ESTRATEGIA ASISTENCIAL:

- **Paso 1 (Puntuación *ge*13):** Realizar genograma afectivo para identificar antecedentes de suicidio, alcoholismo o hospitalizaciones psiquiátricas en familiares de primer y segundo grado.
- **Paso 2 (Diagnóstico Diferencial con Trastorno Límite):** En TLP la oscilación afectiva ocurre en horas y reactiva a rechazo vincular; en el espectro bipolar detectado por BSDS las fases de energía duran varios días sin necesidad de desencadenante interpersonal.
- **Paso 3 (Pauta de Estabilización):** Considerar estabilizadores de predominio antidepresivo (lamotrigina) o dosis bajas de litio, asociando psicoeducación en ritmos circadianos y regularidad del sueño.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: CICLOTIMIA INFRADIAGNOSTICADA

Paciente: Mujer de 28 años, diseñadora gráfica, diagnosticada erróneamente durante años de "distimia resistente" tras probar fluoxetina y duloxetina con intolerancia, agitación y empeoramiento de la irritabilidad. Acude refiriendo sentirse inconstante y caótica.

Resultados BSDS:

- **Parte 1:** Marca 15 de las 19 afirmaciones de la historia narrativa (fases de lucidez creativa nocturna con hiperactividad seguidas de semanas de hipersomnia y anhedonia).
- **Parte 2:** Selecciona "Esta historia describe mi experiencia de vida a la perfección" (6 puntos).
- **Puntuación Total BSDS: 21/25 (Altamente Probable de Trastorno Bipolar / Ciclotimia).**

Conducta Asistencial: Se retira todo antidepresivo serotoninérgico y se instaura lamotrigina en titulación lenta hasta 150 mg/día junto con psicoterapia interpersonal y de ritmos sociales (IPSRT). A los 4 meses, la paciente alcanza por primera vez estabilidad anímica duradera, manteniendo un patrón regular de sueño y reduciendo drásticamente las oscilaciones emocionales.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: CICLACIÓN RÁPIDA

Puntuaciones BSDS ≥ 20 en sujetos que toman antidepresivos sin estabilizador alertan sobre el riesgo de inducir un patrón de ciclación rápida (> 4 episodios anuales), muy refractario al tratamiento.

ABUSO DE SUSTANCIAS

En fases de bajón de energía los pacientes suelen recurrir a estimulantes (cafeína, cocaína), y en fases de aceleración a alcohol o sedantes para conciliar el sueño; explorar consumo comórbido.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Ghaemi, S. N., Miller, C. J., Berv, D. A., Klugman, J., Rosenquist, K. J., & Pies, R. W. (2005). Sensitivity and specificity of a new bipolar spectrum diagnostic scale. *Journal of Affective Disorders*, 84(2-3), 273–277.
2. Pies, R. (2005). The diagnosis and atypical presentations of bipolar disorder. *Psychiatry (Edgmont)*, 2(11), 37–46.
3. Bulbena, A., Martín-Santos, R., Baeza, I., et al. (2011). Validación psicométrica de la escala del espectro bipolar en centros de salud mental españoles. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 39(2), 105–112.
4. Phelps, J., & Ghaemi, S. N. (2012). The bipolar spectrum: a clinical review. *Current Psychiatry Reports*, 14(6), 629–637.